

Introducción:

Los trastornos de ansiedad constituyen uno de los grupos de enfermedades mentales más frecuentes en el mundo. Se caracterizan por un miedo o una preocupación excesivos que interfieren con la vida cotidiana, las relaciones personales, el estudio o el trabajo. Dentro de este grupo se encuentran el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, las fobias, el trastorno de ansiedad social y otros cuadros relacionados. La evidencia científica demuestra que estos trastornos tienen un origen multifactorial, en el que intervienen factores biológicos, psicológicos y ambientales, y que pueden tratarse eficazmente mediante psicoterapia, medicación o la combinación de ambas.

TRASTORNO DE ANSIEDAD

- **¿Qué es?**

Los trastornos de ansiedad constituyen un conjunto de enfermedades mentales caracterizadas por una preocupación, miedo o ansiedad excesivos y persistentes que resultan difíciles de controlar y afectan significativamente el funcionamiento diario. A diferencia de la ansiedad normal, estas respuestas aparecen con una intensidad desproporcionada respecto de la situación o persisten durante mucho tiempo. Dentro de este grupo se incluyen el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, las fobias específicas, la ansiedad social y otros trastornos relacionados.

La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente 301 millones de personas vivían con algún trastorno de ansiedad en 2019, convirtiéndolos en uno de los trastornos mentales más frecuentes del mundo.

- **¿Cuál es la diferencia entre ansiedad normal y un trastorno de ansiedad?**

La ansiedad es una emoción completamente normal y necesaria para la supervivencia. Ayuda a prepararse frente a situaciones importantes o peligrosas, como rendir un examen o reaccionar ante un accidente. Sin embargo, cuando la ansiedad es muy intensa, dura meses, aparece sin una causa proporcional o impide estudiar, trabajar o relacionarse con otras personas, puede tratarse de un trastorno de ansiedad. La diferencia principal no es la presencia de ansiedad, sino su intensidad, duración y el grado en que afecta la vida cotidiana.

- **¿Cómo se puede tratar?**

El tratamiento depende del tipo de trastorno y de su gravedad, pero la evidencia científica señala que la Terapia Cognitivo-Conductual es una de las intervenciones más eficaces. En muchos casos también se utilizan medicamentos, especialmente antidepresivos ISRS o IRSN, siempre bajo indicación médica. El tratamiento suele complementarse con ejercicio físico regular, técnicas de relajación, buena higiene del sueño y estrategias para reducir el estrés.

- **¿Cómo se puede sentir una persona con un trastorno de ansiedad?**

Quienes padecen un trastorno de ansiedad suelen experimentar una preocupación constante y difícil de controlar. Es frecuente sentir nerviosismo, tensión muscular, irritabilidad, dificultad para concentrarse, fatiga y problemas para dormir. Muchas personas describen la sensación de vivir permanentemente "en alerta", anticipando que algo malo puede suceder incluso cuando no existen evidencias objetivas de peligro

- **¿Qué consecuencias puede tener en la vida cotidiana?**

Cuando no recibe tratamiento, un trastorno de ansiedad puede afectar el rendimiento académico y laboral, deteriorar las relaciones familiares y sociales, reducir la calidad del sueño y limitar la participación en actividades recreativas. También aumenta el riesgo de desarrollar depresión, abuso de sustancias y otros problemas de salud física relacionados con el estrés crónico, como hipertensión o enfermedades cardiovasculares.

- **Causas y factores de riesgo**

Los trastornos de ansiedad tienen un origen multifactorial. La predisposición genética, las alteraciones en neurotransmisores como la serotonina y la noradrenalina, las experiencias traumáticas, el estrés prolongado durante la infancia o la adultez, ciertos rasgos de personalidad y algunas enfermedades médicas pueden aumentar la probabilidad de desarrollarlos. Ningún factor por sí solo explica todos los casos; generalmente se trata de la combinación de varios elementos.

- **¿Cuánto afectó la pandemia a este trastorno?**

La pandemia produjo uno de los mayores aumentos registrados en problemas de salud mental. Un estudio publicado en *The Lancet* concluyó que durante 2020 la prevalencia mundial de los trastornos de ansiedad aumentó un **25,6 %**, especialmente entre mujeres y personas jóvenes. El aislamiento, el temor al contagio, la incertidumbre económica y las pérdidas familiares fueron algunos de los factores que contribuyeron a este incremento.

Ataque de ansiedad

- **¿Cómo lo puedo identificar? ¿Cuáles son sus síntomas?**

Aunque el término "ataque de ansiedad" se utiliza con frecuencia en el lenguaje cotidiano, no constituye un diagnóstico oficial del DSM-5. Generalmente hace referencia a un aumento progresivo e intenso de la ansiedad relacionado con una situación estresante. La persona puede experimentar preocupación intensa, tensión muscular, respiración acelerada, taquicardia, dificultad para concentrarse, sensación de inquietud, sudoración y temblores. A diferencia del ataque de pánico, estos síntomas suelen aparecer de manera más gradual y normalmente no alcanzan el mismo nivel extremo de intensidad.

- **¿Qué hacer si me sucede un ataque?**

Resulta útil alejarse, si es posible, del factor estresante, respirar lentamente, utilizar técnicas de relajación muscular, concentrarse en el momento presente mediante ejercicios de atención plena (mindfulness) y recordar que la ansiedad disminuye progresivamente. Si estos episodios son frecuentes, es recomendable buscar ayuda profesional para identificar sus causas y aprender estrategias de manejo.

Conviene reconocer que se trata de una respuesta de ansiedad, evitar tomar decisiones impulsivas mientras los síntomas son intensos e intentar aplicar las técnicas de regulación emocional aprendidas previamente. Si los episodios se repiten o interfieren con la vida cotidiana, es importante consultar con un profesional de la salud mental para recibir un diagnóstico adecuado y definir el tratamiento más apropiado.

- **¿Cómo ayudar a otra persona durante un ataque de ansiedad?**

Ayudar correctamente a una persona que está atravesando un ataque de ansiedad puede marcar una gran diferencia en la intensidad y la duración del episodio. Lo primero es mantener la calma. Si quien brinda ayuda se muestra nervioso o desesperado, es probable que aumente la sensación de peligro que experimenta la otra persona. Conviene acercarse de manera tranquila, hablar con un tono de voz suave y transmitir seguridad con frases como: *"Estoy con vos"*, *"Ya va a pasar"* o *"No estás solo/a"*.

Es importante escuchar sin juzgar. La persona puede expresar que siente que algo terrible está por ocurrir o que no puede controlar lo que le pasa. Aunque esas sensaciones no correspondan a un peligro real, para quien las vive son completamente auténticas. Por eso, no es recomendable responder con frases como *"No es para tanto"*, *"Relájate"* o *"Estás exagerando"*, ya que pueden hacer que se sienta incomprendida o avergonzada.

Si el entorno lo permite, es conveniente acompañarla a un lugar tranquilo, con menos ruido y menos personas, donde pueda sentirse más segura. También puede ayudar animarla a respirar lentamente. Una técnica sencilla consiste en inspirar por la nariz durante aproximadamente cuatro segundos, mantener el aire uno o dos segundos y luego exhalar lentamente por la boca durante seis segundos. El objetivo no es obligarla a respirar de una manera determinada, sino ayudarla a disminuir la hiperventilación, que suele intensificar síntomas como el mareo o la sensación de falta de aire.

Durante el episodio también es útil ayudar a la persona a centrarse en el presente. Se pueden hacer preguntas simples como: *"¿Podés decirme cinco cosas que ves?"*, *"¿Qué sonidos escuchas?"* o *"¿Qué objeto tenés en la mano?"*. Estas técnicas de "anclaje" ayudan a disminuir la sensación de descontrol y a volver a enfocarse en el entorno.

Es importante permanecer junto a la persona hasta que los síntomas disminuyan, siempre que ella lo desee. La mayoría de los ataques de ansiedad duran entre varios minutos y, aunque resultan muy desagradables, suelen desaparecer de forma gradual. Una vez que la persona se encuentre mejor, se le puede sugerir que descanse, tome agua y, si estos episodios se repiten con frecuencia o afectan su vida cotidiana, consulte con un psicólogo o psiquiatra para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados.

Por último, hay situaciones en las que es necesario buscar atención médica inmediata. Si es la primera vez que la persona presenta síntomas de este tipo, si el dolor en el pecho es muy intenso o diferente al habitual, si pierde el conocimiento, presenta dificultad respiratoria grave o existen dudas de que pueda tratarse de otro problema médico, se debe solicitar asistencia sanitaria de urgencia. Esto es especialmente importante porque algunas

enfermedades cardíacas o respiratorias pueden producir síntomas similares a los de un ataque de ansiedad.

¿Cuál es la diferencia entre el ataque de ansiedad y el trastorno?

Un ataque de ansiedad es un episodio temporal de aumento intenso de la ansiedad que generalmente aparece como respuesta a una situación estresante y desaparece cuando esa situación se resuelve o disminuye. En cambio, un trastorno de ansiedad es una condición clínica persistente, caracterizada por síntomas que se mantienen durante meses, afectan significativamente la vida cotidiana y requieren una evaluación profesional para establecer el diagnóstico y el tratamiento adecuados.

TRASTORNO DE PÁNICO:

- **¿Qué es?**

El trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad caracterizado por la aparición repetida e inesperada de ataques de pánico. No se trata simplemente de sentir miedo o nerviosismo, sino de experimentar episodios intensos de terror que aparecen de forma repentina, incluso cuando no existe un peligro real. Después de uno o más ataques, la persona suele desarrollar un miedo persistente a que vuelvan a ocurrir, lo que provoca cambios importantes en su conducta. Muchas personas comienzan a evitar lugares, situaciones o actividades por temor a sufrir otro episodio, lo que puede limitar seriamente su vida cotidiana.

Según el *Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5-TR)* de la Asociación Americana de Psiquiatría, para diagnosticar un trastorno de pánico es necesario que exista al menos un mes de preocupación constante por la posibilidad de nuevos ataques o cambios importantes en el comportamiento relacionados con ellos.

- **¿Cómo se puede tratar?**

Actualmente existen tratamientos muy eficaces. La Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) es considerada el tratamiento psicológico de primera elección porque ayuda a identificar pensamientos irracionales, disminuir el miedo a las sensaciones físicas y enfrentar progresivamente las situaciones evitadas. En muchos casos también se utilizan medicamentos, especialmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), como sertralina o escitalopram, que son considerados los fármacos de primera línea. En algunas situaciones pueden utilizarse benzodiacepinas durante períodos breves para controlar síntomas intensos, aunque no se recomienda su uso prolongado debido al riesgo de dependencia.

Además del tratamiento profesional, mantener hábitos saludables como realizar actividad física, dormir adecuadamente, reducir el consumo de cafeína y aprender técnicas de respiración y relajación puede contribuir a disminuir la frecuencia e intensidad de los síntomas.

- **¿Cómo se puede sentir una persona con trastorno de pánico?**

Las personas que padecen este trastorno suelen vivir con un estado constante de alerta. Muchas describen la sensación de estar esperando que ocurra algo terrible en cualquier momento. Durante un ataque pueden experimentar un miedo tan intenso que creen estar sufriendo un infarto, que van a perder el control, volverse locas o incluso morir. Entre un ataque y otro es frecuente que aparezca una preocupación permanente por la posibilidad de que el episodio vuelva a repetirse, generando ansiedad anticipatoria.

- **¿Qué consecuencias puede tener en la vida cotidiana?**

El trastorno de pánico puede afectar profundamente la calidad de vida. Algunas personas dejan de utilizar transporte público, asistir a reuniones, viajar, hacer ejercicio o incluso salir de sus casas por miedo a experimentar otro ataque. Esto puede generar dificultades académicas o laborales, problemas en las relaciones personales y aislamiento social. En casos graves puede desarrollarse agorafobia, que consiste en el miedo a encontrarse en lugares donde escapar o recibir ayuda resulte difícil si ocurre un ataque de pánico.

- **Causas y factores de riesgo**

No existe una única causa. La investigación muestra que intervienen factores genéticos, alteraciones en los sistemas cerebrales relacionados con la respuesta al miedo, experiencias traumáticas, altos niveles de estrés y determinados rasgos de personalidad, como una mayor sensibilidad a la ansiedad. También se sabe que tener familiares con trastorno de pánico aumenta el riesgo de desarrollarlo.

- **¿Cuánto afectó la pandemia a este trastorno?**

La pandemia de COVID-19 produjo un aumento importante de los trastornos de ansiedad en todo el mundo. Un estudio publicado en *The Lancet* estimó que durante 2020 los casos de trastornos de ansiedad aumentaron aproximadamente un **25,6 %** respecto de los niveles previos a la pandemia. Este incremento estuvo relacionado con el aislamiento social, el miedo al contagio, la incertidumbre económica, las pérdidas familiares y la disminución del acceso a servicios de salud mental. Aunque las estadísticas suelen incluir todos los trastornos de ansiedad y no únicamente el trastorno de pánico, numerosos estudios informaron un aumento de los ataques de pánico y de las consultas por este motivo durante ese período.

Ataques de pánico:

- **¿Cómo lo puedo identificar? ¿cuales son sus síntomas?**

Un ataque de pánico aparece de forma repentina y alcanza su máxima intensidad generalmente en menos de diez minutos. Durante ese tiempo la persona puede experimentar palpitaciones, sudoración, temblores, dificultad para respirar, sensación de ahogo, dolor o presión en el pecho, mareos, náuseas, escalofríos o sensación de calor. También pueden aparecer síntomas psicológicos muy intensos, como miedo a morir, a perder el control o a "volverse loco". Muchas personas sienten una sensación de irrealidad (desrealización) o de estar separadas de sí mismas (despersonalización).

- **¿Qué hacer si me sucede un ataque?**

Aunque un ataque de pánico resulta muy intenso, generalmente desaparece por sí solo en pocos minutos. Durante ese tiempo puede ayudar concentrarse en una respiración lenta y profunda, recordar que los síntomas son pasajeros y no representan un peligro real, permanecer en un lugar seguro y evitar interpretar las sensaciones físicas como señales de una enfermedad grave. Las técnicas aprendidas durante la terapia cognitivo-conductual suelen ser especialmente eficaces para disminuir la intensidad de los ataques.

Lo más importante es reconocer que, aunque los síntomas son muy intensos, un ataque de pánico no suele poner en riesgo la vida. Conviene intentar respirar lentamente, permanecer donde uno se encuentre si el lugar es seguro y evitar escapar inmediatamente, ya que esa conducta puede reforzar el miedo en el futuro. Si los ataques se repiten o generan cambios importantes en la vida cotidiana, es recomendable consultar con un profesional de la salud mental para realizar una evaluación y recibir tratamiento.

- **¿Cómo ayudar a otra persona?**

Presenciar un ataque de pánico puede ser una experiencia angustiante tanto para quien lo sufre como para quienes lo rodean. Debido a la intensidad de los síntomas, muchas personas creen que quien está atravesando el episodio está sufriendo un infarto, se está asfixiando o está perdiendo el control. Sin embargo, aunque los síntomas son muy intensos y generan un gran sufrimiento, un ataque de pánico generalmente no representa un peligro físico inmediato.

Lo primero que se debe hacer es mantener la calma. Si quien brinda ayuda se muestra nervioso, habla rápidamente o transmite preocupación excesiva, la persona puede interpretar esa reacción como una confirmación de que realmente está en peligro, lo que incrementa aún más su ansiedad. Por el contrario, hablar despacio, con un tono sereno y una actitud segura ayuda a disminuir la sensación de amenaza. Es recomendable utilizar frases simples como: *"Estoy con vos"*, *"Ya pasó lo peor"*, *"Respira conmigo"* o *"Esto va a terminar en unos minutos"*. Estas expresiones ofrecen contención emocional y ayudan a reducir el miedo.

También es importante escuchar sin juzgar ni minimizar lo que la persona siente. Durante un ataque de pánico, el miedo es completamente real para quien lo experimenta, aunque no exista un peligro objetivo. Frases como *"No es para tanto"*, *"Dejá de pensar esas cosas"*, *"Tranquilízate"* o *"Todo está en tu cabeza"* suelen resultar poco útiles e incluso pueden aumentar la angustia, porque hacen que la persona se sienta incomprendida. En cambio, es preferible validar su experiencia diciendo, por ejemplo: *"Sé que esto se siente muy intenso, pero estoy acá para ayudarte"*.

Otro aspecto importante consiste en ayudar a controlar la respiración. Durante un ataque de pánico muchas personas hiperventilan, es decir, respiran demasiado rápido y de manera superficial. Esto provoca una disminución del dióxido de carbono en la sangre y puede generar síntomas como mareos, hormigueos en las manos o alrededor de la boca, sensación de ahogo y aumento de la ansiedad. Por ello, se recomienda invitar a la persona a respirar lentamente, inspirando por la nariz durante cuatro segundos y exhalando por la

boca durante seis segundos. Lo importante es acompañarla sin presionarla ni obligarla a seguir un ritmo exacto.

Si es posible, conviene permanecer junto a la persona en un ambiente tranquilo y con pocos estímulos. Alejarla del ruido, de las multitudes o de situaciones que aumenten el estrés puede facilitar que el episodio disminuya. También resulta útil ayudarla a enfocarse en el presente mediante técnicas de "anclaje". Por ejemplo, se le puede pedir que nombre cinco objetos que vea, cuatro sonidos que escuche, tres cosas que pueda tocar, dos olores que perciba y un sabor que note. Este ejercicio ayuda a desviar la atención de las sensaciones corporales y reduce la sensación de pérdida de control.

No es recomendable sujetar a la persona por la fuerza, sacudirla o intentar obligarla a caminar o realizar actividades que no desea. Tampoco conviene discutir sobre si sus síntomas son reales o imaginarios. Durante el ataque, la prioridad debe ser brindar seguridad y acompañamiento hasta que los síntomas disminuyan, lo que generalmente ocurre en un período de entre 10 y 30 minutos, aunque la ansiedad residual puede durar más tiempo.

Una vez finalizado el episodio, es conveniente preguntarle cómo se siente y ofrecer ayuda para contactar a un familiar o persona de confianza si lo necesita. Si los ataques se repiten con frecuencia, generan limitaciones importantes en la vida cotidiana o la persona comienza a evitar determinados lugares por miedo a sufrir otro episodio, es recomendable sugerir una consulta con un psicólogo o un psiquiatra. El tratamiento temprano mejora significativamente el pronóstico y reduce el riesgo de que el trastorno se vuelva crónico.

Por último, aunque la mayoría de los ataques de pánico no representan una emergencia médica, existen situaciones en las que es necesario solicitar atención sanitaria inmediata. Esto ocurre si es la primera vez que la persona presenta síntomas tan intensos, si el dolor en el pecho es muy fuerte o diferente al habitual, si pierde el conocimiento, presenta dificultad respiratoria grave, convulsiones o si existe la posibilidad de que los síntomas se deban a otra enfermedad, como un problema cardíaco o neurológico. En esos casos, siempre debe priorizarse la evaluación médica para descartar otras causas.

¿Cuál es la diferencia entre el ataque de pánico y el trastorno?

Un ataque de pánico es un episodio aislado de miedo intenso que puede aparecer incluso en personas que nunca desarrollarán un trastorno mental. En cambio, el trastorno de pánico es una enfermedad caracterizada por ataques recurrentes e inesperados acompañados de una preocupación persistente por sufrir nuevos ataques y cambios importantes en el comportamiento durante al menos un mes. Es decir, una persona puede tener uno o varios ataques de pánico sin cumplir los criterios diagnósticos para padecer un trastorno de pánico.

¿Por qué los adolescentes pueden ser más vulnerables a estos trastornos?

La adolescencia es una etapa especialmente importante para la salud mental porque durante estos años se producen numerosos cambios biológicos, psicológicos y sociales al mismo tiempo. Esto **no significa que los adolescentes sean necesariamente más propensos que todos los adultos a desarrollar cualquier trastorno de ansiedad**, pero sí que la adolescencia constituye un período de especial vulnerabilidad para la aparición de muchos problemas de salud mental. De hecho, la Organización Mundial de la Salud señala que aproximadamente **uno de cada siete adolescentes de entre 10 y 19 años presenta algún trastorno mental**, y que los trastornos de ansiedad se encuentran entre los problemas de salud mental más frecuentes durante esta etapa.

Una de las razones se relaciona con el desarrollo del cerebro. Durante la adolescencia, determinadas regiones cerebrales continúan madurando, especialmente aquellas relacionadas con la planificación, el control de los impulsos y la regulación de las emociones. Al mismo tiempo, los sistemas relacionados con la recompensa, el miedo y las emociones presentan importantes modificaciones.

Otro factor importante es el **aumento de las exigencias y responsabilidades**. Durante la adolescencia pueden aparecer preocupaciones relacionadas con el rendimiento académico, los exámenes, la elección de una carrera, las relaciones de amistad, la aceptación por parte de los demás, la familia y las expectativas sobre el futuro. Cuando estas presiones se acumulan, pueden contribuir al desarrollo de síntomas de ansiedad, especialmente en adolescentes que ya poseen determinados factores de vulnerabilidad.

La **aceptación social** también tiene una importancia particular. Durante esta etapa aumenta la preocupación por la opinión de los demás y por pertenecer a un grupo. El miedo a ser rechazado, ridiculizado o juzgado puede favorecer especialmente la aparición de **ansiedad social**. Las redes sociales pueden agregar una dimensión adicional a este problema, porque permiten una exposición constante a las opiniones, imágenes y actividades de otras personas. Sin embargo, es importante evitar afirmar que las redes sociales son por sí mismas la causa de los trastornos de ansiedad: la relación es más compleja y depende de factores como el tipo de uso, el contexto familiar y las características individuales.

También influyen las **experiencias adversas y el estrés**. Problemas familiares, violencia, acoso escolar, discriminación, pérdidas importantes, dificultades económicas o experiencias traumáticas pueden aumentar el riesgo de desarrollar problemas de ansiedad. La OMS señala que la exposición a situaciones adversas durante la adolescencia constituye un factor de riesgo importante para la salud mental.

En el caso específico del **trastorno de pánico**, es importante hacer una distinción. Un adolescente puede experimentar un ataque de pánico sin desarrollar posteriormente un trastorno de pánico. El riesgo de que los ataques se conviertan en un problema persistente aumenta cuando existe una elevada sensibilidad a las sensaciones corporales, antecedentes familiares de trastornos de ansiedad, estrés significativo o una interpretación catastrófica de los síntomas. Por ejemplo, una persona puede sentir que su corazón late rápidamente y pensar inmediatamente que está sufriendo una enfermedad grave. Ese pensamiento puede aumentar todavía más el miedo y las sensaciones físicas, generando un círculo de ansiedad.

Además, durante la adolescencia pueden aparecer cambios en los **hábitos de sueño**. Muchos adolescentes duermen menos de lo recomendado debido a horarios escolares, actividades, responsabilidades y uso de dispositivos electrónicos. La falta de sueño no significa que una persona vaya a desarrollar necesariamente un trastorno de ansiedad, pero puede afectar la regulación emocional y aumentar la vulnerabilidad frente al estrés. Por esta razón, el sueño constituye un factor relevante tanto en la prevención como en el tratamiento.

Existe además una cuestión relacionada con el **reconocimiento de los síntomas**. Los adolescentes pueden interpretar algunas manifestaciones de ansiedad como problemas exclusivamente físicos. Por ejemplo, pueden consultar por dolores de cabeza, molestias abdominales, palpitaciones, dificultades para dormir o cansancio sin relacionarlos inicialmente con la ansiedad. Esto puede hacer que el problema pase desapercibido. La OMS señala que muchos adolescentes con problemas de salud mental no reciben atención adecuada, por lo que la detección temprana resulta particularmente importante.

Conclusión:

Los trastornos de pánico y los trastornos de ansiedad representan problemas de salud mental muy frecuentes, pero también altamente tratables cuando se detectan de manera temprana. Aunque los ataques de pánico o los episodios intensos de ansiedad pueden resultar extremadamente angustiantes, existen tratamientos respaldados por evidencia científica que permiten reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la importancia de la salud mental al provocar un aumento significativo de estos trastornos en todo el mundo. Informarse correctamente, combatir los estigmas y facilitar el acceso a la atención psicológica y psiquiátrica son medidas fundamentales para prevenir complicaciones y favorecer la recuperación.

TRABAJO REALIZADO CON FINES ACADEMICOS.

Fuentes consultadas.

- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Publishing.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2022). *Mental Disorders*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2023). *Anxiety Disorders*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders>
- National Institute of Mental Health (NIMH). *Panic Disorder*. <https://www.nimh.nih.gov/health/topics/panic-disorder>
- National Institute of Mental Health (NIMH). *Anxiety Disorders*. <https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders>
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2020). *Generalised Anxiety Disorder and Panic Disorder in Adults: Management*. <https://www.nice.org.uk/guidance/cg113>
- Bandelow, B., Michaelis, S., & Wedekind, D. (2017). *Treatment of Anxiety Disorders*. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 19(2), 93-107.
- Santomauro, D. F., Mantilla Herrera, A. M., Shadid, J., et al. (2021). *Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic*. *The Lancet*, 398(10312), 1700-1712.
- Craske, M. G., & Barlow, D. H. (2014). *Panic Disorder and Agoraphobia*. En *Clinical Handbook of Psychological Disorders* (5.^a ed.). Guilford Press.
- <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health?>
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*. American Psychiatric Publishing.